

시 정 사 항

1. 제 목 : 영상진단료 판독가산 청구 부적정
2. 관계기관 : □□병원, ○○병원, △△병원, ◇◇병원, ☆☆병원, @@실
3. 내 용 : □□병원에서는 국가유공자 및 지역주민 진료시 환자의 질환에 대한 정확한 진단을 위해 단순영상촬영, MRI·CT 등 특수영상촬영 등 검사를 시행하여 촬영된 영상을 판독하고, 해당 영상진단료를 「국민건강보험법」 제44조(비용의 일부부담) 및 제47조(요양급여비용의 청구와 지급 등) 한국보훈복지의료공단운영 규정 제19조(심사평가원 심사청구 방법과 처리기준) 등에 따라 환자 및 건강보험심사평가원에 청구하여 수익처리하고 있습니다.

「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제1편 제2부 제3장 제1절(방사선단순영상진단료) 및 제2절(방사선특수영상진단료)에 따르면 당해 요양기관에 상근하는 영상의학과 전문의가 판독을 하고 판독소견서를 작성한 경우에는 소정점수의 10%를 가산한다. 다만 “영상저장 및 전송시스템(Full PACS)을 이용하여 필름을 사용하지 않은 경우 부여되는 소정점수” 및 “C-Arm¹⁾형 영상증폭장치이용료”에 대하여는 그러하지 아니한다고 하였습니다.

또한 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」의 방사선 영상진단의 판독료 산정 기준에서 판독소견서는 환자치료(치료계획) 전까지 작성하여야 하며, 부득이한 사정이 있는 경우에는 건강보험심사평가원에 요양급여비용을 청구하기 전까지는 작성하여야 한다고 명시하고 있습니다.

따라서 각 □□병원에서는 상근하는 영상의학과 전문의가 판독한 건에 대해서는 해당 영상진단료에 10%가산하고, 요양급여비용을 청구하기 전까지 자체 상근하는 영상의학과 전문의가 판독하지 않았거나 외부위탁판독을 한 경우에는 가산하지 않고 환자 및 건강보험심사평가원 등으로 청구하여야 합니다.

1) C-Arm : 부분적으로 방사선을 투과해 실시간으로 뼈나 신경 등의 상태를 보여주는 수술용 투시조영장비

그런데 각 □□병원에서는 일부 의료영상에 대해 요양급여비용을 청구하기 전까지 상근하는 영상의학과 전문의가 판독하지 않았는데도 판독가산료(영상진단료에 10%가산)를 청구하여 국비 및 감면보상금 등으로 판독가산료 총 ***,***건, ***,***,***을 잘못 정산하였으며, 건강보험부담금 및 본인실부담금으로 총 ***,***건, ***,***,***원도 잘못 청구하였습니다.

4. 조치할 사항

○ □□ · ○ ○ · △ △ · ◇ ◇ · ☆ ☆ 병원장은

- 영상진단료 판독가산(10%)에 대해 과다 정산한 국비보상금(국비 및 감면 보상금) ***,**,**원(□□병원 **,**,**원, ○○병원 **,**,**원, △△병원 **,**,**원, ◇◇병원 **,**,**원, ☆☆병원 **,**,**원)은 @@@@로 환급조치 하시고,(시정)
- 과다 청구한 건강보험부담금 및 본인실부담금 ***,**,**원(○ ○ 병원 **,**,**원, △ △ 병원 **,**,**원, ◇ ◇ 병원 **,**,**원)원은 건강보험 심사평가원에 신고 후 결과 통보 시 환급조치 하시기 바랍니다.(시정)

○ @@이사는

- 영상진단료 판독가산(10%)이 과다 청구되는 일이 없도록 6개 □
병원과 대책방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

시 정 사 항

1. 제 목 : 요양병원 인력확보 수준에 따른 입원료 차등제 관리 부적정
2. 관계기관 : □□병원
3. 내 용 : □□병원에서는 환자의 상태에 적합한 진료서비스 제공을 위해 399 병상 규모의 □□요양병원을 운영하고 있고, 의사 인력확보 수준에 따른 입원료 차등제를 적용하고 있습니다.

「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치 점수」 제3편 제3부 요양병원 행위 급여목록 상대가치점수 및 산정지침 4. 라. 의사인력 확보수준에 따른 입원료 차등제에 따르면, 직전 분기 평균 환자 수 대비 당해 요양기관에 상근하는 의사 수(환자 수 대 의사 수의 비)에 따라 의사인력 확보수준을 1등급 내지 5등급으로 구분하며, 1등급에 해당하는 요양병원은 의사 중 전문의(내과, 외과, 신경과, 정신건강의학과, 재활의학과, 가정의학과, 신경외과, 정형외과) 수가 50% 이상인 경우와 50% 미만인 경우로 구분하여 산정하도록 규정되어 있으며, 세부기준은 [표 1]과 같습니다.

[표 2] 의사인력 확보수준에 따른 입원료 차등제 기준

구분	등급	기준	수가적용
의사	1등급	35:1	전문의 50%이상 - 20%가산 전문의 50%미만 - 10%가산
	2등급	35:1초과 40:1이하	소정점수
	3등급	40:1초과 50:1이하	소정점수 15%감산
	4등급	50:1초과 60:1이하	소정점수 30%감산
	5등급	60:1초과	소정점수 50%감산

또한 공단 「복무규정」 제27조에서 연차 휴가는 직원이 자유의사에 따라

1년간에 한하여 적치하여 분할 사용할 수 있으며, 공단은 직원이 청구한 시기에 연차휴가를 주는 것이 사업운영상 막대한 지장이 있다고 인정될 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다고 명시하고 있습니다.

따라서 □□요양병원에서는 의사 인력 확보수준에 따라 수가 차등제가 적용되고 있으므로 필요 인력을 적기에 수급하여 당초 계획한 등급을 적용받을 수 있도록 관리하여야 하며, 의사 당직 근무표 작성 및 휴가 승인 시에는 의사인력 확보 수준에 따라 입원료 차등제에 미치는 영향을 감안하여 근무표를 조정하거나 연차 휴가 및 시간선택제 근무 신청에 대한 승인여부를 결정하여 최적의 등급을 받을 수 있도록 하여야 합니다.

그런데 '17년 2분기 □□요양병원의 차등수가 적용 실태를 확인한 결과, 입원료 차등제에 미치는 영향을 고려하지 않고 일반의 ○○○에 대해 장기간 휴가를 부여하고, '17.1월 당직 근무 편성시에도 포함하지 않고 작성하는 등 1개월 동안 1일도 근무하지 않았으며, 일반의 △△△에 대해서는 시간선택제(30시간/주) 근무를 승인하여 상근 근무가 인정되지 않으나 실제 근무한 사실과 다르게 상근 근무한 의사인력으로 산정하였습니다.

그 결과 '17. 2분기 의사인력 등급을 2등급이 아닌 1등급 전문의 수 50% 이상 (20% 가산)으로 신고하여 국비(감면)보상금 등 **백만 원 상당, 건강보험(의료급여)부담금 등 **백만 원 상당을 과다 청구하였습니다.

4. 조치할 사항

○ □□병원장은

- 요양병원 입원료 차등제 의사등급을 잘못 적용하여 발생한 차액분 **,***,***원 (국비 및 감면보상금 : **,***,***원, 기타감면액 : ***,***원)을 환급 및 정산 조치 하시기 바랍니다.(시정)

기 관 경 고

1. 제 목 : 영상진단 판독 및 청구 관리 부적정
2. 관계기관 : □□·○○·△△·◇◇ 병원
3. 내 용 : □병원에서는 X-Ray 등 단순영상촬영 및 MRI·CT 등 특수영상 촬영 검사를 실시·판독하여 환자들 질환에 대한 정확한 진단을 하고 있습니다.

보건복지부 고시 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제1편 제2부 제3장 제1절(방사선단순영상진단료) 및 제2절(방사선특수영상진단료)에는 상근하는 영상의학과 전문의가 판독을 하고 판독소견서를 작성한 경우에는 해당 영상진단료에 소정점수의 10%를 가산하여 건강보험심사평가원으로 청구하도록 되어 있습니다.

또한 위 고시에는 전문의가 판독 소견서를 작성하지 않은 경우에는 촬영료 등(소정점수의 70%)만 산정하도록 되어 있으며, 판독소견서 작성 시점은 환자치료(치료계획) 전까지로 하되, 부득이한 사정이 있는 경우에는 건강보험심사평가원에 요양급여비용을 청구하기 전까지 작성하여야 한다고 되어 있습니다.

그러므로 각 □병원에서는 영상촬영 후 요양급여 및 국비보상금 청구(정산) 등은 상근하는 영상의학과 전문의가 판독한 경우에만 10%의 가산수가를 청구하여야 하고, 전문의가 요양급여비용 청구전까지 판독소견서를 작성한 경우에만 판독료(소정점수의 30%)를 포함하여 수가의 100%를 청구함으로써 부당 청구 등 논란의 소지가 없도록 관리하여야 합니다.

그러나 □□·○○·△△·◇◇ 보훈병원에서는 영상의학과 전문의들의 정원 부족 등을 사유로 촬영한 영상의 판독을 적기에 하지 못하였고, 진료과 전문의들은

업무과중 또는 청구기준 미숙지 등의 사유로 적기에 촬영한 영상을 미판독하거나, 판독을 하였으나 판독소견서를 작성하지 못한 사례가 발생하였습니다. 또한 □부(○부)에서는 영상촬영 시 이루어지는 수납과 판독 및 청구시점 차이, 심사 대상 수량의 과다로 인한 문제 등으로 인해 검사 건별로 확인이 곤란하다는 사유 등으로 판독가산(10%) 해당 여부, 전문의 판독여부(수가의 30%)를 확인하지 않고 일괄 청구(정산)하여왔습니다.

그 결과 상근하는 영상의학과 전문의 판독에 의한 가산료(10%) 청구분 중 국비부담금 816백만원(□□ 361, ○○ 282, △△ 100, ◇◇ 73백만 원) 및 건강보험 부담금 등 248백만 원(○○ 130, △△ 74, ◇◇ 44백만 원)상당이 잘못 정산되었으며, 전문의 판독(수가의 30%) 여부에 따른 청구분 중에도 국비부담금 434백만원(□□ 337, ○○ 2, △△ 2, ◇◇ 93백만 원) 및 건강보험부담금 등 198백만 원(□□ 163, ○○ 1, △△ 1, ◇◇ 33백만 원)상당이 잘못 정산된 것으로 추정되었습니다.

4. 조치할 사항

○ 이사장은

- 영상진단료 청구 시 일부 의료영상에 대해 상근하는 영상의학과 전문의가 판독하지 않았는데도 판독가산료(영상진단료 10%가산)를 잘못 청구하거나, 진료과 전문의들이 판독소견을 작성하지 않았는데도 (영상진단료 30%해당) 이를 구분 청구하지 않아 결과적으로 부당청구의 소지를 제공하는 등 영상진단 판독 및 청구를 부적절하게 관리한 □□·○○·△△·◇◇ 보훈병원에 동일사례 재발방지를 위하여 「기관경고」 조치하시기 바랍니다.(기관경고)

개 선 사 항

1. 제 목 : 의료영상정보시스템을 이용한 외부판독 의뢰 절차에 관한 사항
2. 관계기관 : □□병원
3. 내 용 : □□병원에서는 국가유공자 및 지역주민 진료시 환자의 질환에 대한 정확한 진단을 위해 단순영상촬영, MRI·CT 등 특수영상촬영 등 검사를 시행하고 의료영상정보시스템을 이용하여 자체판독 또는 외부에 위탁하여 판독을 수행하고 있습니다.

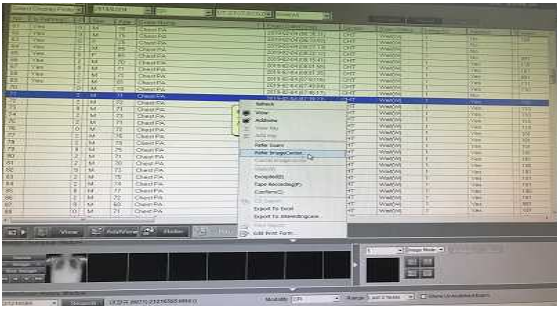
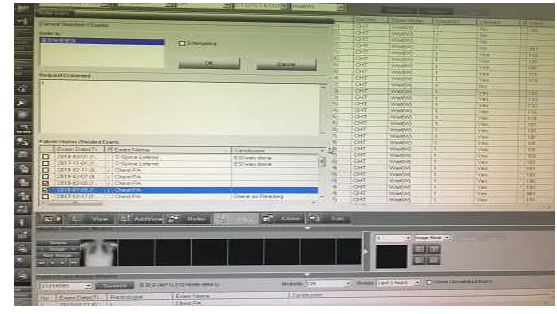
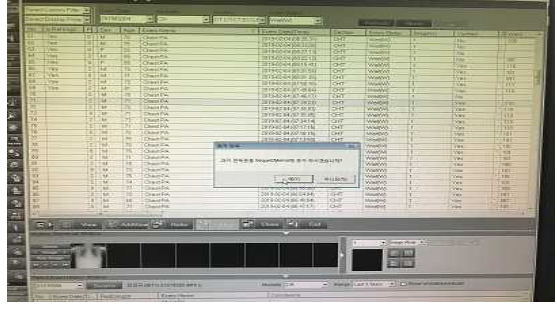
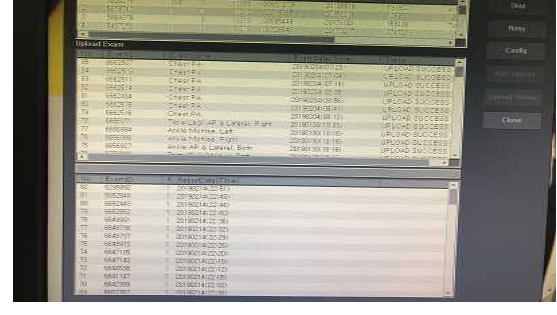
보건복지부 고시 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제2부 제3장 영상진단 및 방사선치료료 산정지침에서 영상진단을 실시한 경우에는 반드시 판독소견서를 작성·비치하여야 한다고 명시하고 있습니다.

따라서 □□병원에서는 촬영한 영상에 대해 자체판독이 가능한 건에 대해서는 조속히 의료영상정보시스템(2)PACS)에 판독소견을 입력하고, 외부로 판독을 위탁해야 할 영상은 적기에 전송 처리하여 판독소견이 작성·비치될 수 있도록 해야 합니다.

그런데 □□병원에서는 촬영한 의료영상을 외부에 판독 의뢰 시 1일평균 1,500여 건의 영상에 대해 일괄 처리하여 전송하는 것이 아니라 [그림 1]과 같이 의뢰할 영상마다 환자의 동일 검사 건에 대한 과거 영상자료를 첨부하는 등 건별로 수기로 작업하고 있어 외부로 판독의뢰를 하는 단순작업에만 4시간 이상 소요되고 있습니다.

2) PACS(Picture Archiving and Communication System ; 의료영상정보시스템) : X선, CT, MRI 등에 의해 촬영된 의료용 영상정보의 저장, 판독 및 검색 기능 등의 수행을 통합적으로 처리하는 시스템

[그림 1] 의료영상정보시스템 내 외부판독 의뢰 절차

	
① 의뢰할 영상 선택	② 환자의 최근 동일 검사 영상 선택
	
③ 과거영상 첨부하여 의뢰영상 전송	④ 전송결과 확인

그 결과 영상판독대기 해소를 위해 촬영이 완료된 건에 대하여 1일 평균 *,**건 상당의 영상자료를 외부 위탁 업체로 전송해야함에도 작업 소요시간이 장시간 소요됨에 따라 의뢰대상 촬영영상의 절반수준인 *,**건을 의뢰하고 있습니다.

4. 조치할 사항

○ □□병원장은

- 촬영한 의료영상을 외부에 판독의뢰 시 효율적으로 처리할 수 있도록 의료영상정보시스템(PACS)의 외부위탁 처리 프로세스 개선하여 적기에 판독이 이루어질 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.(개선)

통 보 사 항

1. 제 목 : 영상진단 판독료 청구에 관한 사항
2. 관계기관 : □□병원, ○○병원, △△병원, ◇◇병원, ☆☆병원, @@실
3. 내 용 : □병원에서는 환자의 진료와 관련하여 촬영한 단순영상, MRI·CT 등 의료영상을 판독하여 진료에 활용하고, 해당 영상진단료를 환자 및 건강보험심사평가원에 청구하여 수익처리하고 있습니다.

「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제1편 제2부 행위 급여 목록·상대가치점수 및 산정지침 제3장 영상진단 및 방사선치료료 산정지침에서 판독소견서를 작성·비치하지 아니한 경우에는 촬영료 등(소정점수의 70%)만 산정한다고 하였습니다. 그리고 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」의 방사선 영상진단의 판독료 산정 기준에서 판독소견서는 환자치료(치료계획) 전까지 작성하여야 하며, 부득이한 사정이 있는 경우에는 건강보험심사평가원에 요양급여비용을 청구하기 전까지는 작성하여야 한다고 명시하고 있습니다.

따라서 각 □병원에서는 요양급여비용을 청구하기 전까지 부득이하게 판독소견서를 작성·비치하지 않은 경우, 영상진단료 수가에서 판독료 30%를 제외한 촬영료에 해당하는 70% 금액만 환자 및 건강보험심사평가원 등으로 청구하여야 합니다.

그런데 각 □□병원의 특수영상에 대해 영상진단료 청구현황을 조사한 결과 일부 의료영상에 대해 판독을 하지 않았을 것으로 추정됨에도 판독료(영상진단료 수가의 30%)를 청구하여 국비 및 감면보상금 등으로 판독료 총 **,***건, ***,***천 원(□□병원 ***,***천 원, ○○병원 *,***천 원, △△병원 *,***천 원, ◇◇병원 **,***천 원) 상당을, 건강보험부담금 및 본인실부담금으로 총 *,***건, ***,***천 원(□□병원 ***,***천 원, ○○병원 ***,***천 원, △△병원 *,***천 원, ◇◇병원 **,***천 원) 상당을 잘못 청구하였을 것으로 추정되었습니다.

4. 조치할 사항

○ □이사(□□·○○·△△·◇◇·☆☆ 병원장)는

- 미판독하였으나 청구한 특수영상 판독료(영상진단료의 30%)가 ***,***천 원 (국비정산 ***,***천 원, 건강보험 및 본인실부담금 ***,***천 원) 상당으로 추정되어 자료를 송부하오니 일반촬영, 핵의학영상진단 및 골밀도검사료 등 자료를 보완하여 자율점검을 통해 잘못 정산(청구)한 판독료를 바로잡을 수 있는 방안을 검토하시고,(통보)

※ 외부기관(□□□□부 등) 조사 대상 건은 자율점검 시 제외.

- 미판독한 영상진단료가 잘못 청구되거나 정산되는 일이 없도록 6개 □병원과 대책방안을 마련하여 주시기 바랍니다.(통보)